

a9_nursing_assessment 测试报告

生成时间：2026-05-08 20:17:59

测试时间：2026-05-08 20:17:59

- 一、测试目的：验证工具增强对输出质量提升作用。
- 二、测试内容：同一输入下，分别运行 use_tools=True/False。
- 三、测试方法：对比输出结构与长度，核对产物路径。
- 四、测试过程：
 - 1) 启用工具运行；
 - 2) 禁用工具运行；
 - 3) 指标对照；
 - 4) 结论归纳。

五、测试结果：

启用工具 success=True chars=1880 markers=36

禁用工具 success=True chars=1556 markers=28

工具说明：tool_照护洞察:tool_照护洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_个性化健康档案:tool_个性化健康档案：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_体征洞察:tool_体征洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_用药洞察:tool_用药洞察：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_健康评估记录:tool_健康评估记录：从长者智能计算图提取历史参考证据
tool_睡眠记录:tool_睡眠记录：从长者智能计算图提取历史参考证据

六、结论：工具可显著提升智能体输出准确性、完整性与专业性，助力机构提供更精准照护与医疗服务。

【启用工具输出摘录】

《护士评估结论与调整建议》

评估日期：2026-05-08

评估类型：D5护士评估

NPI结论：

NPI评分为15分，属中度精神行为异常。核心问题为拒绝配合康复训练及集体活动，表现为对结构化干预的抵触情绪。此行为可能加速功能退化，需优先干预。

ADL结论：

ADL评分为70分，提示轻度功能障碍。老人可独立完成进食、穿衣、如厕及大小便控制；平地行走及上下楼梯需部分辅助；洗澡需照护员全程协助。除洗澡外，其余日常生活能力保留良好。

进食评估结论：

可独立进食，进食过程无呛咳、吞咽困难等异常表现，营养摄入途径安全。

睡眠评估结论：

夜间睡眠规律，总睡眠时长约7.2小时，夜醒1次，睡眠质量总体稳定，无需药物干预。

当前风险判断：

中等风险。主要风险点包括：(1)

因拒绝参与康复及集体活动导致的依从性风险，可能影响认知与体能维持；(2)

洗澡过程中因需全程协助且存在平衡能力下降，存在跌倒及烫伤风险。

****护理员调整建议**：**

1. ****强化洗澡安全流程****：确保浴室铺设防滑垫，水温预先调试至安全范围（38-40℃），照护员全程在旁协助，严禁离开。

2. ****引入个性化认知干预****：结合老人“喜好跳舞”的特点，每日安排15-20分钟结构化音乐律动活动（参考视频规程），以非强制方式提升参与意愿，逐步重建活动习惯。

3. ****完善服务记录****：确保康乐活动、洗澡协助等关键环节完整记录，避免漏记影响照护质量评估。

****是否需要GP介入**：**

否。当前病情稳定，风险可通过照护流程优化及非药物干预管理，暂无需医生介入。

****是否更新护理员任务**：**

是。需新增“每日结构化跳舞活动”及“洗澡安全双人核查”任务。

****护理员判断依据**：**

近7天事件记录与ADL量表。

****视频规程链接**：**

<https://care-protocol.local/video/dementia-dance-guideline>

****家属沟通建议**：**

维持每周2次结构化反馈会议，同步老人活动参与进展；继续执行每日用药打卡机制，确保服药依从性透明化。

****《照护员周重点任务》****

****评估日期****：2026-05-08

****评估类型****：D5护士评估

****NPI结论**：**

NPI评分为15分，属中度精神行为异常。核心问题为拒绝配合康复训练及集体活动，表现为对结构化干预的抵触情绪。此行为可能加速功能退化，需优先干预。

****ADL结论**：**

ADL评分为70分，提示轻度功能障碍。老人可独立完成进食、穿衣、如厕及大小便控制；平地行走及上下楼梯需部分辅助；洗澡需照护员全程协助。除洗澡外，其余日常生活能力保留良好。

****进食评估结论**：**

【禁用工具输出摘录】

****《护士评估结论与调整建议》****

- ****NPI结论****：中度精神行为异常（NPI 15分），核心表现为拒绝配合康复训练及集体活动，但保留对跳舞的兴趣，提示行为抗拒可能源于活动形式不适配或环境压力，而非兴趣完全丧失，具备认知行为干预空间。
- ****ADL结论****：轻度日常生活功能障碍（ADL 70分）。可独立完成进食、穿衣、如厕及大小便控制；平地行走及上下楼梯需部分辅助；洗澡需全程协助，为当前主要功能依赖项。
- ****进食评估结论****：独立进食，无呛咳、吞咽困难或进食延迟，营养摄入途径安全。
- ****睡眠评估结论****：睡眠节律稳定，夜间觉醒1次，总睡眠时长约7.2小时，符合老年失智人群正常范围，无显著睡眠障碍。
- ****当前风险判断****：中等风险。主要风险点包括：（1）行为依从性差，可能导致功能退化加速；（2）洗澡过程中因需全程协助且存在平衡能力下降，存在跌倒高风险。
- ****护理员调整建议****：
 - （1）暂停强制参与集体活动，改为基于其“喜好跳舞”的个体化认知-运动干预，每日安排15–20分钟一对一音乐律动或简易舞蹈活动；
 - （2）洗澡环节严格执行防跌倒规程：使用防滑垫、沐浴椅，确保至少1名照护员全程在侧，水温提前调试，避免站立洗浴；
 - （3）在走廊及常用路径增设扶手，强化转移安全。
- ****是否需要GP介入****：否。当前病情稳定，无急性躯体症状，基础疾病（高血压、高脂血症）处于可控状态，建议按计划季度随访。
-
- **是否更新护理员任务****：是。需将个性化舞蹈活动及洗澡安全操作纳入本周照护重点。
- ****护理员判断依据****：近7天照护事件记录与标准化ADL量表评估结果。
- ****视频规程链接****：<https://care-protocol.local/video/dementia-dance-guideline>（失智老人舞蹈干预操作指南，适用于轻中度认知障碍长者）。
- ****家属沟通建议****：实施“每周2次结构化反馈会”（建议固定周二、周五晚间），同步照护进展与行为变化；推行“每日用药打卡”机制，由家属确认服药完成情况，以增强治疗连续性并缓解其长期照护焦虑。

****《照护员周重点任务》****

- ****评估日期****：2026-05-08
- ****评估类型****：D5护士评估
- ****NPI结论****：中度精神行为异常，拒绝集体活动但保留跳舞兴趣，具备个体化干预契机。
- ****ADL结论****：轻度功能障碍，洗澡需全程协助，行走及楼梯需部分辅助。
- ****进食评估结论****：独立进食，无呛咳。
- ****睡眠评估结论****：夜醒1次，总睡眠7.2小时，节律良好。
- ****当前风险判断****：中等风险（依从性风险 + 洗澡跌倒风险）。
- ****护理员调整建议****：